O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vazirligining
2025 yil “____”_____dagi
“_____”-sonli buyrug‘iga
___-ILOVA

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

“SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O`zbekiston Respublikasi sog`liqni
saqlash vaziri
A.A. Xudayarov
_____
«____»_____2025 y .

“SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

“SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT 2025

SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI

NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

XKT-10 bo’yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
I20.8	Turg‘un zo‘riqish stenokardiyasi I-IV FS	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.0	Aterosklerotik yurak-qon tomir kasalligi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.1	Aterosklerotik yurak kasalligi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.2	O‘tkazgan miokard infarkti Sin.: Infarktdan keyingi kardioskleroz	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.6	Og‘riqsiz miokard ishemiyasi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog,	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog,

			endokrinolog, nefrolog, okulist		endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.8	Surunkali yurak ishemik kasalligini boshqa shakllari	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
I25.9	Surunkali yurak ishemik kasalligi aniqlashtirilmagan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist

XKT-11 bo‘yicha kodlanishi:	**Нозологик номланиши:**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
BA40.1	Turg‘un zo‘riqish stenokardiyasi I-IV FS	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA50 — BA6Z	Surunkali yurak ishemik kasalligi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist

BA52	Koronar arteriyalarning aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.0	Nativ koronar arteriyalarning aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.1	Autologik koronar shuntni aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.10	Autologik arterial koronar shuntni aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.11	Autologik venoz koronar shuntni aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.1Z	Autologik aniqlashtirilmagan koronar shuntni aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog,	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog,

			kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist		kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.2	Noautologik koronar shuntni aterosklerozi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA52.Z	Aniqlashtirilmagan lokalizasiyali koronar ateroskleroz	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA50	O‘tkazilgan miokard infarkti	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA81	Koronar arteriyani anevrizmasi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA81.0	Koronar arteriyani anevrizmasi perforasiyasi bilan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog,	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog,

			reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist		reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA81.1	Koronar arteriyani anevrizmasi yorilishi bilan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA81.2	Koronar arteriyani anevrizmasi yorilish yoki anevrizmasiz	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA82	Koronar arteriyani disseksiyasi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA83	Ortirilgan koronar arteriyani fistulasi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA5Y	Boshqa aniqlashtirilgan surunkali yurak ishemik kasalligi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog,	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog,

			endokrinolog, nefrolog, okulist		endokrinolog, nefrolog, okulist
BA5Z	Aniqlashtirilmagan surunkali yurak ishemik kasalligi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist
BA84	Koronar arteriyani surunkali to‘liq okklyuziyasi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist	Kardiolog/Intervension kardiolog/reanimatolog	Intervension kardiolog, kardiojarroh, nevropatolog, reanimatolog, endokrinolog, nefrolog, okulist

***standartni to‘ldirish jarayonida nozologiya, uning kattalar, xomiladorlar, bolalar va qariyalarda kechuvi hamda nozologiya bo‘yicha kasallikni davri xususiyatidan kelib chiqish talab etiladi.**

Shuningdek, nozologiya ga to‘g‘ri kelmaydigan jadvallarni to‘ldirish tavsiya qilinmaydi. (Misol uchun, jarroxlik amaliyoti nozologiyasida o‘tkazilmasa (JARROHLIK AMALIYOTI) jadvali to‘ldirilmaydi yoki nozologiyada palliativ davo ko‘zda tutilmasa – (PALLIATIV DAVO) jadvali to‘ldirilmaydi.

DIAGNOSTIKA, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oilaviy shifokor	+					- I-II FS: yiliga 2 marta;	Ambulator kuzatuv umrbod; Statsionar davolanish: 5-10 kun*
	2. Kardiolog		+	+	+	+	- III-IV FS uchun yiliga 4 marta	
	3. Terapevt		+	+			- I-II FS va SYUIKni boshqa shakllari uchun: yiliga 2 marta;	
Izoh: * statsionar sharoitidagi davolanish muddati bo‘lgan gospitalizatsiya maqsadiga bog‘liq. Statsionar sharoitidagi mutaxassis ko‘riklari har kungi bo‘ladi.								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo‘shimcha)	1. Intervension kardiolog			+	+	+	III-IV FS uchun yiliga 1 marta	
	2. Kardiojarroh				+	+	III-IV FS uchun yiliga 1 marta	
	3. Intervension aritmolog					+	Ko‘rsatmaga binoan	
	4. Nevropatolog		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	5. Endokrinolog		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	6. Nefrolog		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	7. Okulist		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
Izoh: Barcha tor mutaxassislar ko‘rigi ko‘rsatmaga binoan tashkillashtiriladi. Statsionar sharoitada tor mutaxassislarning ko‘rik soni klinik holatiga muvofiq tashkillashtirilishi lozim.								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	+	+	+	- I-II FS va SYuIKni boshqa	
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+	+	+	+		

	3. Qondagi kreatinin	+	+	+	+	+	shakllari uchun: yiliga 2 marta - III-IV FS uchun yiliga 4 marta	
	4. ALT, AST, bilirubin	+	+	+	+	+		
	5. Qondagi qand	+	+	+	+	+		
	6. Umumiy xolesterin	+	+	+	+	+		
	7. Triglitseridlar		+	+	+	+		
	8. YuZLP-Xs		+	+	+	+		
	9. PZLP-Xs		+	+	+	+		
	10. Umumiy KFK		+	+	+	+		
	11. Koagulogramma	+	+	+	+	+		
Izoh: agar OSHP/OP moddiy-texnik bazasi to‘liq lipid spektri bilan umumiy KFK tekshirish imkoyanitiga ega bo‘lsa, oilaviy shifokor tomonidan bu tekshiruvlar bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlar	1. Troponinlar		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	2. MB-KFK			+	+	+		
	3. RW			+	+	+		
	4. Qon guruhi			+	+	+		
	5. Gepatit B va C			+	+	+		
	6. OIV			+	+	+		
	7. MNUP		+	+	+	+		
	8. TTG		+	+	+	+		
	9. Glikirlangan gemoglobin		+	+	+	+		
	10. Elektrolitlar		+	+	+	+		
	11. Umumiy oqsil		+	+	+	+		
	12. Gomotsistein		+	+	+	+		
Izoh: Qon guruhi, gepatit B va C, OIV ga tekshiruvlar KAG va/yoki miokard revaskulyarizatsiyasi (TOKA yoki AKSh) rejalashtirilgan bemorlar uchun bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. EKG	+	+	+	+	+	- I-II FS: yiliga 2 marta; - III-IV FS uchun yiliga 4 marta	
Izoh: Statsionar sharoitida EKGni soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha	1. ExoKG		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga	

instrumental tekshiruvlar	**2. VEM yoki Tredmil-sinamasi**		**+**	**+**	**+**	**+**	**binoan**	
	3. Ko'krak qafasi rentgenografiyasi		**+**	**+**	**+**	**+**		
	4. Koronar kalsiy				**+**	**+**		
	5. Uyqu arteriyalari UTT		**+**	**+**	**+**	**+**		
	6. Xolter bo'yicha EKG ni monitorlash				**+**	**+**		
	7. Stress-ExoKG				**+**	**+**		
	8. MSKT-KAG					**+**		
	9. Invaziv koronarografiya				**+**	**+**		
	10. BFEKT/PET					**+**		
	11. Fraksion qon oqim zaxirasi (FFR), Tomir ichi UTT					**+**		
	12. EGDFS		**+**	**+**	**+**	**+**		
	13. Ichki a'zolar UTT		**+**	**+**	**+**	**+**		
Izoh: Koronar kalsiy va uyqu arteriyalari UTT YuIK skrining tekshiruvlari sifatida barcha DPM darajasida bajarilishi mumkin. Statsionar sharoitida instrumental tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi. EGDFS miokard revaskulyarizatsiyasidan (TOKA yoki AKSh) oldin yoki antitrombotsitar dori vositalarini qabul qiluvchi bemorlarda oshqozon-ichak traktidan qon ketish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda o'tkazilishi lozim.								

Diagnostik tadbirlar	**Tibbiy xizmatlar nomi**	**Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha**					**Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni**	**Davolash muddati**
		Ambulator yordam		**Statsionar yordam**				
		OShP/OP	**KTMP**	**Tuman (shahar) shifoxonalari**	**Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari**	**Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari**		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	**1. Testdan oldingi ehtimollik**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**Birinchi ko'rikda**	
	2. SCORE2 shkalasi	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**SYuIK skriningida qo'llaniladi**	
	3. CHA2DS2-VASc va HAS-BLED shkalalari	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**Har ko'rikda**	

	4. SYNTAX score			+	+	+	KAG o‘tkazilgandan so‘ng miokard revaskulyarizatsiya turini aniqlashda qo‘llaniladi	

Izoh: Testdan oldingi ehtimollik barcha bemorlarda tekshiruv jaroyinadan oldin baholanishi lozim.
SCORE2 YuIKni skrining jaroyinida yurak qon-tomir xavfini baholashda qo‘llaniladigan shkalasi.
YuIK va bo‘lmachalar fibrillyasiyasi bo‘lgan bemorlar ishemik insul't xavfini baholash uchun CHA2DS2-VASc shkalasi qo‘llaniladi.
YuIK va bo‘lmachalar fibrillyasiyasi bo‘lgan bemorlar oral antikoagulyantlar qo‘llanilganda qon ketish ehtimolligini baholash uchun HAS-BLED shkalasi qo‘llaniladi.

(MEDIKAMENTOZ TERAPIYA)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Atsetilsalitsil kislotasi	75-150 mg dan 1 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	75-150 mg	umrbod
2. Statinlar - Rozuvastatin - Atorvastatin	- Rozuvastatin 5-40 mg dan 1 marta sutkasiga - Atorvastatin 10-80 mg dan 1 martma sutkasiga	+	+	+	+	+	- Rozuvastatin 5-40 mg - Atorvastatin 10-80 mg	umrbod
3. RAAT blokatorlari: A) AAF ingibitorlari: - Enalapril - Ramipril - Perindopril B) ARB (sartanlar): - Valsartan - Lozartan - Kandesartan - Telmisartan	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Ramipril 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Perindopril erbumin 2-8 mg 1 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg - Ramipril 2,5-10 mg - Perindopril erbumin 2-8 mg - Perindopil arginin 2,5-10 mg ARB:	umrbod

- Azilsartan - Olmesartan	- Perindopil arginin 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga ARB: - Valsartan – 40-320 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Lozartan 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Kandesartan 4-32 mg 1 marta sutkasiga - Telmisartan 10-80 mg 1 marta sutkasiga - Azilsartan 20-80 mg 1 marta sutkasiga - Olmesartan 10-40 mg 1 marta sutkasiga						- Valsartan – 40-320 mg - Lozartan 25-100 mg - Kandesartan 4-32 mg - Telmisartan 10-80 mg - Azilsartan 20-80 mg - Olmesartan 10-40 mg	
4. Qisqa ta’sir qiluvchi nitratlar: - Nitroglitserin	Nitroglitserin 0,1-1,2 mg faqat stenokardiya xurujlarida til ostiga yo tabletka yo sprey ko‘rinishida qo‘llaniladi	+	+	+	+	+	0,1-1,2 mg	-
5. Beta-blokatorlar: - Bisoprolol - Metoprolol - Nebivalol - Karvedilol	- Bisoprolol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Nebivalol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 marta sutkasiga bo‘linib beriladi	+	+	+	+	+	- Bisoprolol 2,5-10 mg - Metoprolol suksinat 25-100 mg - Nebivalol 2,5-10 mg - Karvedilol 3,125-25 mg	umrbod

6. Degidropiridinli kalsiy kanallari blokatorlari: - Amlodipin - Lerkanidipin - Uzoq ta'sir qiluvchi nifedipin	- Amlodipin 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Lerkanidipin 5-20 mg 1 marta sutkasiga - Nifedipin retard 30-60 mg 1 marta kuniga	+	+	+	+	+	- Amlodipin 2,5-10 mg - Lerkanidipin 5-20 mg - Nifedipin retard 30-60 mg	umrbod
Izoh: RAAT blokatorlari YUIK bor bemorlarda AG, QD va SYuYe bo'lsa qo'llaniladi.								

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Klopidogrel	75 mg 1 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	75 mg	1 yil*
2. Tikagrelor	90 mg 2 marta sutkasiga		+	+	+	+	180 mg	1 yil
3. Prasugrel	5-10 mg 1 marta sutkasiga		+	+	+	+	5-10 mg	1 yil
4. Rivaroksaban	2,5 mg 2 marta sutkasiga		+	+	+	+	5 mg	umrbod**
5. Apiksaban	2,5-5 mg 2 marta sutkasiga		+	+	+	+	5-10 mg	1 yil
6. Ezetimib	10 mg 1 marta sutkasiga		+	+	+	+	10 mg	umrbod
7. Inklisiran	284 mg 1 marta 6 oyda		+	+	+	+	568 mg yillik dozasi	umrbod
8. Fenofibrat	145 mg 1 marta sutkasiga		+	+	+	+	145 mg	umrbod
9. Omega 3	1 g 2 ta kapsuladan 2 marta sutkasiga		+	+	+	+	4 g	umrbod
10. Ivabradin	5-7,5 mg 2 marta sutkasiga		+	+	+	+	10-15 mg	umrbod
11. Uzoq ta'sir qiluvchi nitratlar:	- Izosorbid dinitrat: Ayerozol til ostiga	+	+	+	+	+	60-120 mg	umrbod

- Izosorbid dinitrat - Izosorbid mononitrat	faqat stenokardiya xuriji paytida 1-3 marta sepiladi; tabletkalari - 20 mg kuniga 2-3 marta (yoki kuniga 2 marta 40 mg yoki kuniga 1-2 marta 60 mg); kapsulalar 120 mg dan kuniga 1 marta. - Izosorbid mononitrat: 20-40 mg 2-3 marta sutkasiga							
12. Nodigidropiridinli kalsiy kanallar blokartorlari: - Verapamil - Diltiazem	- Verapamil: 40-80 mg 3-4 marta sutkasiga. Maksimal sutkalik dozasi 480 mg gacha. - Diltiazem: 60 mg 3 marta sutkasiga yoki 90 mg 2 marta sutkasiga. Maksimal sutkalik dozasi 360 mg gacha		+	+	+	+	Verapamil: 160-320 mg Diltiazem: 180 mg	umrbod
13. Trimetazidin	80 mg 1 marta sutkasiga, 35 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	70-80 mg	umrbod
14. Ranolazin	500-1000 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	1000-2000 mg	umrbod

Izoh: Ezetimib, Inklisiran gipolipidemik dovosida 2 va 3 qatordagi dori hisoblanib, statinlarning samadorligi yetmaganda qo‘shiladi.

Fenofibrat va Omega 3 dori vositalari giperxolesterinemiya bilan gipertriglitseridemiya birga kelganda qo‘llaniladi

Verapamil yoki Diltiazem beta-blokator qo‘llash mumkin bo‘lmagan hollarda (bronxial astma, allergik reaksiyalar va b.) tavsiya qilinadi

* Klopidogrelni 1 yillik qo‘llash muddati O‘KS, TOKA yoki AKSH amaliyotlarini o‘kazgan bemorlar uchun. Agar SYuIK bemorida yurak qon-tomir xavfi yuqori bo‘lsa, atsetilsalitsil kislotasi bilan birga umrbod qo‘llanilishi mumkin.

** Rivaroksaban 2,5 mg dan 2 mahal koronar havzasi ko‘p tomirli shikastlanishi bo‘lganda, atsetilsalitsil kislotasi bilan birga umrbod qo‘llanilishi mumkin.

Agar SYuIK li bemorda BF bo‘lsa, rivaroksaban 15-20 mg dan sutkasiga beriladi.

(OPERATIV DAVO)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Teri orqali koronar aralashuv			+	+	+
2. AKSh				+	+
3. Kuchaytirilgan tashqi kontrpulsatsiyasi				+	+
Izoh: TOKA: agar koronar havzasi 1 yoki 2 tomirli shikastlanish (SYNTAX natijasi 32 balldan past) bo‘lsa va optimal medikamentoz terapiyasi samarasi yetarli bo‘lmasa AKSH: agar koronar havzasida 3 va ko‘p tomirli shikastlanish (SYNTAX natijasi 32 balldan yuqori) bo‘lsa, yoki chap toj arteriya o‘zani shikastlanishi bilan, yoki yondosh QD bo‘lsa Kuchaytirilgan tashqi kontrpulsatsiyasi: refrakter stenokardiyali bemorlarda miokard revaskulyarizatsiyasi kuchaytirish maqsadida 35 ta seans tavsiya qilinadi					

(PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. 10-sonli stol umrbod	+	+	+	+	+

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Hamshira	+		Ko‘rsatmaga ko‘ra mutaxassis tomonidan aniqlanadi	Agar bemor O‘MI, TOKA va AKSh o‘tkazgan bo‘lgan, reabilitatsiya 2 oy davomida o‘tkazilishi lozim.
	2. Oilaviy shifokor	+			
	3. Kardiolog		+		
	4. Terapevt		+		
	5. Diyetolog		+		
	6. Fizioterapevt		+		
	7. Tibbiy psixolog		+		
Izoh: SYuIK bo‘lgan bemorning ishlash qobiliyati zo‘riqish stenokardiya va YuYening funksional sinfiga, yondosh kasalliklarga va kasbning xususiyatiga bog‘liq. Yurak ritmi va o‘tkazuvchanligining xavfli buzilishisiz I-II FS zo‘riqish stenokardiyasi bo‘lgan bemorlar kompleks reabilitatsiya dasturi uchun mahalliy kardiologik sanatoriylarga, balneologik va iqlimiy kurortlarga yuborilishi mumkin. III-IV sinf zo‘riqish stenokardiyasi va og‘ir birga keladigan kasalliklari bo‘lgan bemorlarga sanator-kurort va fizioterapevtik davolanish tavsiya etilmaydi					
Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	Shifokor ko‘rigidan so‘ng ko‘rsatmaga binoan tavsiya etiladi.	
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+		
	3. ALT, AST, bilirubin	+	+		
	4. Lipid spektri	+	+		
	5. Qondagi qand miqdori	+	+		
	6. Kreatinin	+	+		
Izoh: qon tahlillar dori vositalarning samadorligini va xavfsizligini baholash uchun tavsiya etiladi					
Instrumental tekshiruvlar	1. EKG	+	+	Shifokor ko‘rigidan so‘ng ko‘rsatmaga binoan tavsiya etiladi.	
	2. ExoKG		+		
	3. Ko’krak qafasi rentgenografiyasi		+		
	4. Xolter bo‘yicha EKG ni monitorlash		+		
	5. VEM yoki tredmil-sinamasi		+		
Izoh: VEM yoki tredmil-sinamasi jismoniy yuklamaga tolerantlikni, prognozi va medikamentoz terapiyani samaradorligi baholash uchun tavsiya etiladi.					
Davolash tadbirlari (medikamentoz davo)		OShP/OP	KTMP	O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi				
1. Atsetilsalitsil kislotasi	75-150 mg dan 1 marta sutkasiga	+	+	75-150 mg	umrbod
2. Klopidogrel	75 mg 1 marta sutkasiga	+	+	75 mg	1 yil
3. Statinlar - Rozuvastatin - Atorvastatin	- Rozuvastatin 5-40 mg dan 1 marta sutkasiga - Atorvastatin 10-80 mg dan 1 martma	+	+	- Rozuvastatin 5-40 mg - Atorvastatin 10-80 mg	umrbod

	sutkasiga				
4. RAAT blokatorlari: **A) AAF ingibitorlari:** **- Enalapril** **- Ramipril** **- Perindopril** **B) ARB (sartanlar):** **- Valsartan** **- Lozartan** **- Kandesartan** **- Telmisartan** **- Azilsartan** **- Olmesartan**	**AAFi:** **- Enalapril 2,5-20 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi** **- Ramipril 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga** **- Perindopril erbumin 2-8 mg 1 marta sutkasiga** **- Perindopil arginin 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga** **ARB:** **- Valsartan – 40-320 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi** **- Lozartan 25-100 mg 1 marta sutkasiga** **- Kandesartan 4-32 mg 1 marta sutkasiga** **- Telmisartan 10-80 mg 1 marta sutkasiga** **- Azilsartan 20-80 mg 1 marta sutkasiga** **- Olmesartan 10-40 mg 1 marta sutkasiga**	**+**	**+**	**AAFi:** **- Enalapril 2,5-20 mg** **- Ramipril 2,5-10 mg** **- Perindopril erbumin 2-8 mg** **- Perindopil arginin 2,5-10 mg** **ARB:** **- Valsartan – 40-320 mg** **- Lozartan 25-100 mg** **- Kandesartan 4-32 mg** **- Telmisartan 10-80 mg** **- Azilsartan 20-80 mg** **- Olmesartan 10-40 mg**	**umrbod**
5. Qisqa ta’sir qiluvchi nitratlar: **- Nitroglitserin**	**Nitroglitserin 0,1-1,2 mg faqat stenokardiya xurujlarida til ostiga yo tabletka yo sprey ko‘rinishida qo‘llaniladi**	**+**	**+**	**0,1-1,2 mg**	**-**
6. Beta-blokatorlar: **- Bisoprolol** **- Metoprolol** **- Nebivalol** **- Karvedilol**	**- Bisoprolol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga** **- Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 marta sutkasiga** **- Nebivalol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga** **- Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 marta sutkasiga bo‘linib beriladi**	**+**	**+**	**- Bisoprolol 2,5-10 mg** **- Metoprolol suksinat 25-100 mg** **- Nebivalol 2,5-10 mg** **- Karvedilol 3,125-25 mg**	**umrbod**
7. Degidropiridinli kalsiy kanallari blokatorlari: **- Amlodipin** **- Lerkanidipin**	**- Amlodipin 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga** **- Lerkanidipin 5-20 mg 1 marta sutkasiga**	**+**	**+**	**- Amlodipin 2,5-10 mg** **- Lerkanidipin 5-20 mg**	**umrbod**

- Uzoq ta’sir qiluvchi nifedipin	- Nifedipin retard 30-60 mg 1 marta kuniga			- Nifedipin retard 30-60 mg	
Izoh: Medikamentoz terapiyaning tarkibi kasallikning og‘irligi va yondosh kasalliklar borligiga qarab o‘zgarishi mumkin.					

(DISPANSERIZATSIYA)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Hamshira	+	+	I-II FS uchun yiliga 2 marta III-IV FS uchun yiliga 4 marta	umrbod
	2. Oilaviy shifokor				
	3. Kardiolog		+		
	4. Nevrolog		+	Ko‘rsatmaga muvofiq	
	5. Endokrinolog		+		
	6. Nefrolog		+		
	7. Oftalmolog		+		
Izoh: Qayta ko‘rik maqsadli AQB, PZLP baholash va antiishemik dori vositalarini dozasi titratsiyalash uchun tashkillashtirilardi. IV FS bo‘lganda qayta ko‘riklar soni ko‘proq bo‘lishi mumkin.					
Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	I-II FS uchun yiliga 2 marta III-IV FS uchun yiliga 4 marta	
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+		
	3. Qondagi qand	+	+		
	4. Qondagi kreatinin	+	+		
	5. Lipid spektri	+	+		
	6. ALT, AST, umumiy KFK	+	+		
	7. Koagulogramma	+	+		
	8. Troponin		+	Ko‘rsatmaga muvofiq	
	9. MV-KFK		+		
	10. TTG		+		
	11. MNUP		+		
	12. Qondagi elektrolitlar: kaliy, natriy, kalsiy		+		
	13. Umumiy oqsil		+		
	14. Gomotsistein		+		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha laborator tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					
Instrumental tekshiruvlar	1. EKG	+	+	I-II FS uchun yiliga 2	

				marta **III-IV FS uchun yiliga 4 marta**	
	2. EXOKG		**+**	**Ko‘rsatmaga muvofiq**	
	3. XMEKG		**+**		
	4. Ko’krak qafasi rentgenografiyasi		**+**		
	5. Braxiotsefal arteriyalarni UTT		**+**		
	6. Ichki a’zolarni UTT		**+**		
	7. VEM yoki tredmil-sinamasi		**+**		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha instrumental tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					